

İnme Hastalığı

İnme, beyne giden kan akışının birdenbire kesilmesiyle ortaya çıkan acil bir durumdur. Kan ya bir damarda tıkanır ya da damar yırtılır. Beyin hücreleri oksijen ve besin alamaz, kısa sürede ölür. Bu da konuşma, hareket, görme veya denge gibi işlevlerin bozulmasına yol açar.

İnmenin üç ana türü vardır: 1) İskemik inme: En sık görüleni. Beyindeki bir damar pıhtı veya daralma ile tıkanır. 2) Hemorajik inme: Beyindeki bir damar yırtılır ve kanama olur. 3) Geçici iskemik atak (TIA): Kan akışı kısa süre kesilir. Belirtiler genellikle birkaç dakika veya saat içinde geçer, kalıcı hasar bırakmaz. Ama ileride asıl inmenin habercisi olabilir.

2021 yılında dünya genelinde yaklaşık 93,8 milyon inme vakası bulunurken aynı yıl 11,9 milyon yeni vaka görülmüştür. İnme, ölüm ve sakatlığa yol açan en önemli nedenlerden biridir. Yetişkinlerin yaklaşık dörtte birinin hayatı boyunca inme geçirme riski vardır. Bu risk son 20 yılda yüzde 50 artmıştır.

İnmenin getirdiği yük (ölüm ve sakatlıkla kaybedilen yıllar) de yükselmiştir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde ölümlerin ve sakatlıkların büyük kısmı görülmektedir. İnmenin küresel ekonomik maliyetinin 890 milyar doları aştığı tahmin edilmektedir.

İnme belirtileri genellikle birden ortaya çıkar. En sık görülenler şunlardır: Yüzde bir tarafta sarkma, kol veya bacakta güçsüzlük, konuşmada bozulma veya anlaşılmasız konuşma, ani denge kaybı veya baş dönmesi, ani görme kaybı

Belirtiler beynin hangi bölgesinin etkilendiğine göre değişir. Sağ yarımküre sol tarafı, sol yarımküre sağ tarafı kontrol eder. Hasarın yeri ve büyüklüğü, kişinin ne kadar etkileneceğini belirler. Bazı inmeler belirgin belirtiler vermez; bunlara “Gizli İnme” denir. Bunlar demans riskini artırabilir.

TIA’nın belirtileri kısa sürer ve tamamen geçer. Ama yine de acil müdahale gerektirir.

İnmenin en önemli değiştirilebilir risk faktörü yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonu olanlarda inme riski neredeyse üç kat artar. Diğer önemli faktörler şunlardır: Sigara, yüksek kolesterol, diyabet, obezite ve hareketsizlik, aşırı tuzlu beslenme, zararlı alkol kullanımı, hava kirliliği, böbrek sorunları

Değiştirilemeyen faktörler arasında yaş -55 yaşından sonra risk her on yılda bir iki kat artar- daha önce inme geçirmiş olmak ve bazı kalp hastalıkları örneğin atriyal fibrilasyon yer alır. -Atriyal fibrilasyonun varlığı yaşla birlikte artar ve 80 yaş üstü hastalarda inmelerin %20-25’ine neden olur.-

Gençlerde (18-55 yaş) inme daha nadirdir ama nedenleri farklıdır. Bu yaş grubunda damar yırtılması (diseksiyon), kalpteki açıklık (patent foramen ovale), bazı pıhtılaşma bozuklukları veya nadir damar iltihapları daha sık rol oynar. Yaşlılarda ise yüksek tansiyon, damar sertliği ve kalp kaynaklı pıhtılar ön plandadır.

Beyin hücreleri sürekli kan akışına ihtiyaç duyar. Kan akışı kesildiğinde hücreler ölür. İskemik inmede damar pıhtı veya plak ile tıkanır. Bu pıhtı beyinde oluşabilir veya vücudun başka yerinden gelebilir. Hemorajik inmede ise zayıf bir damar yırtılır; yüksek tansiyon damarları zamanla zayıflatır.

Beynin farklı bölgeleri farklı işlevleri yönetir. Hasar gören bölgeye göre konuşma, hareket, görme veya düşünme etkilenir.

İnme şüphesi varsa hemen hastaneye gidilmelidir. Tanı için beyin görüntülemesi (BT veya MR) yapılır. Bu, kanama mı yoksa tıkanıklık mı olduğunu gösterir. Genç hastalarda nedeni bulmak için daha fazla tetkik gerekebilir.

Özellikle zaman çok kritiktir. İskemik inmede pıhtı eritici ilaç (örneğin tPA) belirtiler başladıktan sonraki ilk saatlerde verilebilir. Bazı hastalarda damardan pıhtı çıkarma işlemi (trombektomi) yapılır. Hemorajik inmede tansiyon kontrol altına alınır, gerekirse ameliyat düşünülür.

Hastalar özel inme ünitelerinde takip edildiğinde sonuçlar daha iyi olur. Stabil olduktan sonra rehabilitasyon başlar: fizik tedavi, konuşma terapisi, günlük yaşam becerileri ve psikolojik destek gibi.

İnme sonrası ilk günlerde beyin ödemi, yutma güçlüğü, zatürre, nöbet veya omuz ağrısı gibi sorunlar çıkabilir. Uzun vadede kalıcı hareket kısıtlılığı, konuşma bozukluğu, bellek sorunları, depresyon ve bağımsızlık kaybı görülebilir. İnme, demans riskini iki kattan fazla artırır. Gizli inmeler de demansa katkıda bulunabilir.

Gençlerde inme nedenini bulmak için standart yaklaşımlar yetmeyebilir; özel tetkikler gerekir. Ayrıca inme ile demans arasındaki bağlantı gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Ortak risk faktörlerini - yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, hareketsizlik gibi- kontrol etmek hem inme hem demans riskini azaltmaya yardımcı olur.

Sonuç olarak inme büyük ölçüde önlenabilir bir durumdur. Yüksek tansiyonu kontrol etmek, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek ve hareket etmek en etkili adımlardır. Belirtileri tanımak ve hemen yardım istemek ise hayatta kalma ve iyileşme şansını artırır.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2025, December 19). Stroke. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/stroke>
- 2) Murphy SJ, Werring DJ. Stroke: causes and clinical features. Medicine (Abingdon). 2020 Sep;48(9):561-566. doi: 10.1016/j.mpmed.2020.06.002. Epub 2020 Aug 6. PMID: 32837228; PMCID: PMC7409792.
- 3) Feigin VL, Brainin M, Norrving B, Martins SO, Pandian J, Lindsay P, F Grupper M, Rautalin I. World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025. Int J Stroke. 2025 Feb;20(2):132-144. doi: 10.1177/17474930241308142. Epub 2025 Jan 3. PMID: 39635884; PMCID: PMC11786524.
- 4) Heart and Stroke Foundation. (n.d.). Stroke and the brain. <https://www.heartandstroke.ca/search-results-page?q=stroke>
- 5) Krüger, C. (2026, April 10). Childhood ischemic stroke: Why young patients need a different diagnostic approach. ESO / ESOC / Stroke Research <https://eso-stroke.org/juvenile-ischaemic-stroke-why-young-patients-require-a-different-diagnostic-mindset/>

Yayın Tarihi: 1 Eylül 2026

Sorumlu Yazar: Ali Bocakkıtaç/ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi